

secondaire. La constipation peut apparaître pour des raisons psychologiques (p. ex. anxiété d'aller à la selle dans un endroit particulier, ou ensemble plus général de conduites anxieuses ou oppositionnelles) qui entraînent un évitement de la défécation. Les conditions physiologiques prédisposant à la constipation comprennent une poussée inefficace ou une dynamique paradoxale de la défécation, le sphincter externe ou le plancher pelvien se contractant au lieu de se relâcher pendant la poussée pour déféquer. Une déshydratation liée à une maladie fébrile, une hypothyroïdie ou un effet secondaire médicamenteux peuvent également induire une constipation. Lorsque la constipation s'est constituée, elle peut se compliquer de fissure anale, de douleur à la défécation et, ultérieurement, de rétention fécale. La consistance des selles peut varier. Chez certains sujets, les selles peuvent avoir une consistance normale ou quasi normale. Elles peuvent être liquides chez d'autres individus qui ont une incontinence par débordement secondaire à une rétention fécale.

Caractéristiques associées en faveur du diagnostic

L'enfant atteint d'encoprésie se sent souvent honteux et peut vouloir éviter les situations qui pourraient être potentiellement embarrassantes (p. ex. colonie de vacances ou école). Le degré de perturbation est fonction de l'effet de l'encoprésie sur l'estime de soi de l'enfant, du degré d'ostracisme social manifesté par ses camarades, et de l'induction de réactions de colère, de punitions et du rejet de la part des personnes s'occupant de lui. Le barbouillage avec les selles peut être délibéré ou accidentel, résultant d'une tentative de l'enfant pour nettoyer ou camoufler les selles émises involontairement. Lorsque l'incontinence est clairement délibérée, des caractéristiques du trouble oppositionnel avec provocation ou celles du trouble des conduites peuvent être présentes. De nombreux enfants ayant une encoprésie et une constipation chronique sont aussi énurétiques et peuvent présenter un reflux vésico-urétéral associé, ainsi que des infections chroniques des voies urinaires qui peuvent disparaître après traitement de la constipation.

Prévalence

On estime qu'environ 1 % des enfants de 5 ans sont atteints d'encoprésie et que le trouble touche davantage les sujets de sexe masculin que ceux de sexe féminin.

Développement et évolution

On ne fait pas le diagnostic d'encoprésie avant l'âge de 4 ans (ou, pour les enfants ayant un retard du développement, avant un âge mental de 4 ans). Un apprentissage de la propreté insuffisant et incohérent, des stress psychosociaux (p. ex. entrée à l'école ou naissance d'un frère ou d'une sœur) peuvent être des facteurs prédisposants. Deux types évolutifs sont décrits : un type « primaire », dans lequel le sujet n'a jamais acquis la continence fécale, et un type « secondaire », dans lequel la perturbation apparaît après une période où la continence fécale est acquise. L'encoprésie peut durer pendant des années, avec des exacerbations intermittentes.

Facteurs de risque et pronostiques

Facteurs génétiques et psychologiques. La défécation douloureuse peut entraîner une constipation et des comportements de rétention qui favorisent l'apparition d'une encoprésie. L'utilisation de certains médicaments (p. ex. anticonvulsivants, antitussifs) peut majorer la constipation et favoriser l'apparition d'une encoprésie.

Marqueurs diagnostiques

Outre l'examen clinique, l'imagerie du tube gastro-intestinal (p. ex. radiographie abdominale) peut être utilisée afin d'évaluer la rétention des gaz et des matières fécales dans le côlon. Des examens complémentaires tels que le lavement baryté et la manographie anorectale peuvent être pratiqués pour exclure une autre affection médicale telle que la maladie de Hirschsprung.

Diagnostic différentiel

On ne peut faire un diagnostic d'encoprésie, en présence d'une autre affection médicale, que si cette dernière ne peut pas expliquer la constipation. L'incontinence fécale liée à d'autres affections médicales (p. ex. diarrhée chronique, spina bifida, sténose anale) ne justifie pas un diagnostic DSM-5 d'encoprésie.

Comorbidité

L'encoprésie peut s'accompagner d'infections urinaires, et cette comorbidité est plus fréquente chez les sujets féminins.

Autre trouble du contrôle sphinctérien spécifié

Cette catégorie correspond à des tableaux cliniques caractéristiques de troubles du contrôle sphinctérien, entraînant une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants, mais ne remplissant pas tous les critères des troubles spécifiques du contrôle sphinctérien décrits précédemment dans ce chapitre. La catégorie des autres troubles du contrôle sphinctérien spécifiés est utilisée dans des situations où le clinicien décide de communiquer la raison particulière pour laquelle les critères d'aucun trouble du contrôle sphinctérien spécifique ne sont entièrement remplis sur le plan clinique. Cela est fait en notant « autre trouble du contrôle sphinctérien spécifié » puis la raison particulière (p. ex. épisodes d'énurésie récurrents de fréquence insuffisante).

Note de codage : Coder **788.39 (N39.498)** pour autre trouble du contrôle sphinctérien spécifié avec symptômes urinaires ; **787.60 (R15.9)** pour autre trouble du contrôle sphinctérien spécifié avec symptômes fécaux.

Trouble du contrôle sphinctérien non spécifié

Cette catégorie correspond à des tableaux cliniques caractéristiques de troubles du contrôle sphinctérien, entraînant une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants, mais ne remplissant pas tous les critères des troubles spécifiques décrits précédemment dans ce chapitre. La catégorie des troubles du contrôle du contrôle sphinctérien non spécifiés est utilisée dans des situations où le clinicien décide de *ne pas* communiquer la raison particulière pour laquelle la présentation clinique ne remplit pas tous les critères d'un trouble du contrôle sphinctérien spécifique, et inclut des situations où l'on ne dispose pas d'assez d'informations pour poser un diagnostic spécifique (p. ex. en situation d'urgence).

Note de codage : Coder **788.30 (R32)** pour trouble du contrôle sphinctérien non spécifié avec symptômes urinaires ; **787.60 (R15.9)** pour trouble du contrôle sphinctérien non spécifié avec symptômes fécaux.

Référence

Énurésie

von Gontard A, Heron J, Joinson C: Family history of nocturnal enuresis and urinary incontinence: results from a large epidemiological study. J Urol 185(6):2303–2306, 2011 21511300

Page laissée en blanc intentionnellement.

Troubles de l'alternance veille-sommeil

La classification des troubles de l'alternance veille-sommeil dans le DSM-5 est destinée à être utilisée en santé mentale et par des médecins exerçant d'autres spécialités (prenant en charge des patients adultes, gériatriques et pédiatriques). Les troubles de l'alternance veille-sommeil comprennent 10 troubles ou groupes de troubles : l'insomnie, l'hypersomnolence, la narcolepsie, les troubles du sommeil liés à la respiration, les troubles de l'alternance veille-sommeil lié au rythme circadien, les troubles de l'éveil en sommeil non paradoxal, les cauchemars, les troubles du comportement en sommeil paradoxal, le syndrome des jambes sans repos et les troubles du sommeil induits par une substance/un médicament. Les individus souffrant de ces troubles se plaignent typiquement d'une insatisfaction liée à la qualité, au moment de survenue et à la quantité de leur sommeil. La détresse et la déficience qui en résultent la journée sont des caractéristiques essentielles de tous ces troubles de l'alternance veille-sommeil.

La structuration de ce chapitre vise à faciliter le diagnostic différentiel des plaintes concernant la veille et le sommeil et à préciser si le recours à un spécialiste du sommeil est nécessaire pour des évaluations complémentaires et la planification d'un traitement. La nosologie des troubles du sommeil dans le DSM-5 utilise une approche simple et utile sur le plan clinique tout en reflétant les progrès scientifiques survenus depuis le DSM-IV en épidémiologie, en génétique, en physiopathologie et en recherche évaluative et interventionnelle. En fonction de l'existence de validateurs provenant de la recherche épidémiologique, neurobiologique et interventionnelle, une approche « de regroupement » a été adoptée dans certains cas (p. ex. pour l'insomnie), alors que dans d'autres (p. ex. pour la narcolepsie), une approche « de séparation » a été utilisée.

Les troubles du sommeil sont souvent accompagnés de dépression, d'anxiété et de modifications des cognitions dont il faut tenir compte dans le plan de prise en charge thérapeutique. De plus, des perturbations du sommeil persistantes (insomnie ou somnolence excessives) sont des facteurs de risque avérés de maladies mentales et de trouble de l'usage d'une substance. Ils peuvent aussi représenter un prodrome d'un épisode d'une maladie mentale, ce qui permet d'envisager une intervention précoce pour prévenir ou atténuer un véritable épisode.

Le diagnostic différentiel des plaintes concernant la veille et le sommeil nécessite une approche pluridimensionnelle et la prise en compte d'éventuelles affections médicales et neurologiques coexistantes. La coexistence avec une affection clinique est la règle et non l'exception. Les perturbations du sommeil représentent un indicateur clinique utile pour repérer les affections médicales et neurologiques qui coexistent fréquemment avec la dépression et d'autres troubles mentaux courants. Les principales comorbidités sont les troubles du sommeil liés à la respiration, les maladies cardiaques et pulmonaires (p. ex. insuffisance cardiaque congestive, pneumopathie obstructive chronique), les maladies neurodégénératives (p. ex. maladie d'Alzheimer) et les maladies du système musculosquelettique (p. ex. arthrose). Ces maladies peuvent non seulement perturber le sommeil mais aussi s'aggraver pendant le sommeil (p. ex. apnées prolongées ou arythmies électrocardiographiques pendant le sommeil paradoxal, éveils confusio- nnels chez des patients souffrant de démence, crises convulsives chez des patients

présentant une épilepsie partielle complexe). Le trouble du comportement en sommeil paradoxal est souvent un marqueur précoce d'une maladie neurodégénérative (alpha-synucléopathie) comme la maladie de Parkinson. Pour toutes ces raisons – en relation avec le diagnostic différentiel, la comorbidité clinique, la facilitation de la prise en charge thérapeutique – les troubles du sommeil font partie du DSM-5.

L'approche utilisée pour classifier les troubles de l'alternance veille-sommeil dans le DSM-5 doit se situer dans le contexte de la dichotomie « regroupement *versus* séparation ». Dans un effort de simplification, la classification des troubles veille-sommeil du DSM-IV rassemblait des diagnostics au sein de larges catégories peu différenciées. D'un autre côté, la deuxième édition de la Classification internationale des troubles du sommeil (ICSD-2)¹ avait défini de nombreux sous-types diagnostiques. Le DSM-IV a été élaboré pour une utilisation en santé mentale et par des médecins cliniciens généralistes n'ayant pas d'expertise en médecine du sommeil. L'ICSD-2 reflétait les avancées scientifiques et l'opinion de la communauté des spécialistes du sommeil et avait été élaborée pour une utilisation par des spécialistes.

Les éléments probants disponibles montrent qu'une approche simple, peu différenciée du diagnostic des troubles de l'alternance veille-sommeil présente des caractéristiques de performance supérieures (fidélité interjuges ainsi que validité convergente, discriminante et apparente). Le texte accompagnant chaque série de critères diagnostiques propose des liens vers le trouble correspondant de l'ICSD-2. La classification du DSM-5 des troubles de l'alternance veille-sommeil spécifie également les codes non psychiatriques correspondants (p. ex. codes neurologiques) provenant de la Classification internationale des maladies (CIM).

Le domaine de la médecine des troubles du sommeil a évolué dans ce sens depuis la publication du DSM-IV. Des validateurs biologiques sont maintenant incorporés dans la classification du DSM-5 des troubles de l'alternance veille-sommeil, particulièrement pour les troubles de somnolence excessive comme la narcolepsie, pour les troubles respiratoires liés au sommeil, pour lesquels une étude formelle du sommeil (c.-à-d. une polysomnographie) est indiquée et pour le syndrome des jambes sans repos, qui coexiste fréquemment avec les mouvements périodiques du sommeil, mis en évidence par une polysomnographie.

Insomnie

Critères diagnostiques

307.42 (F51.01)

- A. La plainte essentielle concerne une insatisfaction liée à la quantité ou à la qualité du sommeil, associée à un (ou plusieurs) des symptômes suivants :
 1. Difficulté d'endormissement. (Chez l'enfant, il peut s'agir de difficulté d'endormissement sans l'intervention d'un tiers responsable.)
 2. Difficulté de maintien du sommeil caractérisée par des réveils fréquents ou des problèmes à retrouver le sommeil après un éveil. (Chez l'enfant, il peut s'agir de difficultés à retrouver le sommeil sans l'intervention d'un tiers responsable.)
 3. Réveil matinal précoce assorti d'une incapacité de se rendormir.
- B. La perturbation du sommeil est à l'origine d'une détresse marquée ou d'une altération du fonctionnement dans les domaines social, professionnel, éducatif, scolaire ou dans d'autres domaines importants.
- C. Les difficultés de sommeil surviennent au moins 3 nuits par semaine.

1. NDT. *International Classification of Sleep Disorders, 2nd Edition.*

- D. Les difficultés de sommeil sont présentes depuis au moins 3 mois.
- E. Les difficultés de sommeil surviennent malgré l'adéquation des conditions de sommeil.
- F. L'insomnie n'est pas mieux expliquée par un autre trouble de l'alternance veille-sommeil ni ne survient exclusivement au cours de ce trouble (p. ex. narcolepsie, trouble du sommeil lié à la respiration, trouble du sommeil lié au rythme circadien, parasomnie).
- G. L'insomnie n'est pas imputable aux effets physiologiques d'une substance (p. ex. substance donnant lieu à abus, médicament).
- H. La coexistence d'un trouble mental ou d'une autre affection médicale n'explique pas la prédominance des plaintes d'insomnie.

Spécifier si :

Avec une comorbidité d'un trouble mental non lié au sommeil, y compris les troubles de l'usage de substances

Avec une autre comorbidité médicale

Avec un autre trouble du sommeil

Note de codage : Le code 307.42 (F51.01) s'applique quelle que soit la spécification. Mentionner le code du trouble pertinent (trouble mental, affection médicale ou autre trouble du sommeil) immédiatement après le code de l'insomnie pour indiquer l'association.

Spécifier si :

Épisodique : Symptômes présents depuis au moins 1 mois mais moins de 3 mois.

Persistant : Symptômes présents depuis 3 mois ou plus.

Récurrent : Au moins deux épisodes sur une période d'un an.

N.B. : L'insomnie aiguë et l'insomnie de courte durée (c.-à-d. la présence de symptômes qui, hormis une durée inférieure à 3 mois, remplissent tous les critères de fréquence, de sévérité, de détresse et/ou d'altération du fonctionnement) doivent être codées comme une autre insomnie spécifiée.

N.B. : Le diagnostic d'insomnie est posé qu'elle survienne isolément ou qu'elle soit comorbide d'un autre trouble mental (p. ex. un trouble dépressif caractérisé), d'une autre affection médicale (p. ex. la douleur) ou d'un autre trouble du sommeil (p. ex. un trouble du sommeil lié à la respiration). Par exemple, l'insomnie peut évoluer selon un cours qui lui est propre avec quelques caractéristiques anxieuses et dépressives mais sans remplir les critères d'un trouble mental. L'insomnie peut aussi être la manifestation clinique d'un trouble mental plus caractérisé. L'insomnie persistante peut même représenter un facteur de risque pour la dépression ([Baglioni et al. 2011](#)) et elle est un symptôme résiduel fréquemment observé après traitement. Lorsque l'insomnie est comorbide d'un trouble mental, le traitement devra si besoin cibler les deux conditions. En raison de ces évolutions cliniques différentes, il est souvent impossible d'établir la nature précise des relations entre ces entités cliniques, et ces relations peuvent changer au fil du temps. Par conséquent, en présence d'une insomnie comorbide d'un autre trouble, il n'est pas nécessaire d'établir une relation causale entre les deux conditions. Le diagnostic d'insomnie doit plutôt être établi en spécifiant parallèlement la condition clinique comorbide. Un diagnostic concomitant d'insomnie doit être considéré seulement lorsque l'insomnie est suffisamment grave pour nécessiter une prise en charge clinique indépendante ; sinon un diagnostic distinct n'est pas nécessaire.

Caractéristiques diagnostiques

La particularité essentielle d'une insomnie est une insatisfaction liée à la quantité ou à la qualité du sommeil, associée à une plainte à propos de difficultés d'initiation ou de maintien du sommeil. Les plaintes concernant le sommeil s'accompagnent d'une

détresse marquée ou d'une altération du fonctionnement dans les domaines social, professionnel ou dans d'autres domaines importants. La perturbation du sommeil peut survenir isolément ou au cours d'un autre trouble mental ou d'une affection médicale.

Plusieurs formes d'insomnie peuvent se manifester à différents moments de la période de sommeil. *L'insomnie d'endormissement* (ou *insomnie initiale*) est caractérisée par des difficultés d'initiation du sommeil au moment de l'endormissement. *L'insomnie de maintien* (ou *insomnie du milieu de nuit*) se caractérise par des éveils fréquents ou prolongés pendant la nuit. *L'insomnie de fin de nuit* se caractérise par un éveil matinal précoce avec incapacité à se rendormir. La présentation clinique la plus fréquente comporte une combinaison de ces symptômes et la difficulté à maintenir le sommeil est le symptôme le plus fréquemment rencontré isolément, suivi par la difficulté d'endormissement (Morin et al. 2006 ; Ohayon 2002 ; Roth et al. 2006). Le type de plaintes concernant le sommeil varie souvent en fonction du temps. Les sujets se plaignant de difficultés d'endormissement à un moment peuvent subséquemment se plaindre de troubles du maintien du sommeil et vice versa. Bien que les symptômes en rapport avec les difficultés d'initiation et de maintien du sommeil puissent être quantifiés par des auto-questionnaires rétrospectifs, des agendas de sommeil ou d'autres méthodes comme l'actigraphie ou la polysomnographie, le diagnostic d'insomnie repose sur une perception subjective du sommeil par l'individu ou rapportée par un tiers responsable.

Le sommeil non réparateur, une plainte à propos d'un sommeil de mauvaise qualité laissant l'individu non reposé au réveil malgré une quantité de sommeil adéquate est généralement associé à des difficultés d'initiation ou de maintien du sommeil et survient moins fréquemment de façon isolée. Cette plainte peut aussi être associée à d'autres troubles du sommeil (p. ex. trouble du sommeil lié à la respiration). Lorsqu'une plainte de sommeil non récupérateur survient isolément (c.-à-d. en l'absence de difficultés d'initiation et/ou de maintien du sommeil) et en présence de tous les critères diagnostiques de fréquence, durée, détresse et altération du fonctionnement diurne, le diagnostic autre insomnie spécifiée ou insomnie non spécifiée est posé.

En dehors des critères de fréquence et de durée requis pour poser le diagnostic, des critères additionnels sont utiles pour quantifier la sévérité de l'insomnie (Ohayon et Reynolds 2009 ; Ohayon et al. 2012). Ces critères quantitatifs sont arbitraires et donnés seulement à titre indicatif. Par exemple, les difficultés d'endormissement sont définies comme une latence d'endormissement subjective de plus de 20-30 minutes, et les difficultés de maintien du sommeil comme un temps d'éveil subjectif après endormissement de plus de 20-30 minutes (Lichstein et al. 2003 ; Lineberger et al. 2006). Bien qu'il n'existe pas de définition standard pour le réveil matinal précoce, ce symptôme comporte un éveil précédant d'au moins 30 minutes l'heure prévue et pour un temps total de sommeil ne dépassant pas 6 heures ½. Il est essentiel de tenir compte non seulement de l'heure du réveil terminal mais aussi de l'heure du coucher le soir précédent. Un éveil à 4 h n'a pas la même signification clinique chez une personne au lit à 21 h et chez une personne au lit à 23 h. Ce type de symptôme peut aussi être lié à l'âge et refléter une diminution de capacité à maintenir le sommeil associée à l'âge ou un avancement de la période de sommeil principale.

L'insomnie comporte des difficultés de sommeil nocturne ainsi que des altérations du fonctionnement diurne. Celles-ci englobent de la fatigue ou, moins fréquemment, de la somnolence diurne, cette dernière étant plus répandue chez les sujets âgés et lorsque l'insomnie est comorbide avec une autre affection médicale (p. ex. douleurs chroniques) ou avec un autre trouble du sommeil (p. ex. apnées du sommeil). L'altération des performances cognitives peut comprendre des difficultés d'attention, de concentration et de mémoire, et même dans la réalisation d'une tâche manuelle simple. Les troubles de l'humeur associés sont décrits comme étant typiquement de l'irritabilité ou une

labilité thymique et moins fréquemment comme des symptômes dépressifs ou anxieux (Buysse et al. 2007). Certaines personnes ayant des perturbations du sommeil nocturne ne s'en plaignent pas ou ne présentent pas d'altération de leur fonctionnement. Par exemple, une discontinuité du sommeil est souvent présente chez des sujets âgés en bonne santé qui s'estiment toutefois être de bons dormeurs. Un diagnostic d'insomnie doit être réservé aux individus présentant une détresse marquée ou une altération du fonctionnement liée aux difficultés de sommeil nocturne.

Caractéristiques associées en faveur du diagnostic

L'insomnie est souvent associée à une activation physiologique et cognitive et à des facteurs de conditionnement qui interfèrent avec le sommeil. Une préoccupation et une détresse liées à l'incapacité de trouver le sommeil peuvent contribuer au développement d'un cercle vicieux : plus l'individu s'efforce de dormir, plus il devient frustré et moins il s'avère capable de dormir. Une attention excessive portée au sommeil et des efforts d'endormissement démesurés outrepassent les mécanismes normaux de l'endormissement et peuvent donc contribuer au développement de l'insomnie (Espie 2002). Les individus présentant une insomnie persistante peuvent aussi acquérir au cours de l'évolution de la maladie des habitudes de sommeil inadaptées (p. ex. temps excessif passé au lit, horaires erratiques de sommeil, siestes en journée) ou des cognitions erronées (p. ex. crainte de ne pas trouver le sommeil, appréhension des répercussions diurnes de l'insomnie, surveillance permanente de l'heure). S'engager dans de telles conduites dans un environnement où le sujet a vécu de nombreuses nuits sans sommeil peut encore augmenter l'éveil conditionné et perpétuer les difficultés de sommeil. Inversement, le sujet peut s'endormir plus facilement s'il n'essaie pas de le faire. Certains individus rapportent qu'ils dorment mieux ailleurs que dans leur propre chambre à coucher et en dehors de leurs conditions habituelles.

L'insomnie peut être accompagnée par diverses plaintes et symptômes diurnes (Buysse et al. 2007), comme de la fatigue, une diminution de l'énergie et des perturbations de l'humeur. Des symptômes anxieux ou dépressifs ne remplissant pas les critères d'un trouble mental spécifique peuvent être présents ainsi qu'une très grande sensibilité aux répercussions diurnes d'un manque de sommeil.

Les individus présentant de l'insomnie peuvent obtenir des notes élevées aux questionnaires d'autoévaluation psychologique ou aux inventaires de personnalité avec des profils montrant une légère dépression et anxiété, un style cognitif inquiet, un mode émotionnel et intériorisé de résolution de conflits et une focalisation sur des problèmes somatiques. Les performances neurocognitives d'individus présentant une insomnie sont altérées de façon irrégulière, bien que la réalisation de tâches très complexes ou nécessitant de fréquentes modifications de stratégie puisse être altérée (Fortier-Brochu et al. 2012). Les individus présentant de l'insomnie déploient souvent plus d'efforts pour maintenir une performance cognitive.

Prévalence

Des estimations reposant sur des études de population indiquent qu'environ un tiers des adultes rapporte des symptômes d'insomnie, 10 à 15 % des perturbations diurnes associées, et 6 à 10 % les symptômes requis pour le trouble insomnie. L'insomnie est le trouble du sommeil le plus fréquent. En médecine générale, environ 10 à 20 % des individus se plaignent de symptômes d'insomnie significatifs (Ohayon 2002 ; Roth et al. 2006). L'insomnie est plus prévalente chez la femme que chez l'homme avec un ratio d'environ 1,44/1. Bien que l'insomnie puisse être un symptôme ou un trouble par elle-même, elle est souvent observée comme une affection comorbide avec une autre

affection médicale ou avec un autre trouble mental. Par exemple, 40 à 50 % des individus présentant de l'insomnie ont aussi une comorbidité avec un trouble mental.

Développement et évolution

Les symptômes d'insomnie peuvent survenir à n'importe quel moment de la vie mais le premier épisode est plus courant chez le jeune adulte. Moins fréquemment, l'insomnie débute dans l'enfance ou l'adolescence. Chez la femme, le premier épisode peut survenir pendant la ménopause et persister même après la résolution d'autres symptômes (p. ex. bouffées de chaleur). L'insomnie peut avoir une survenue tardive dans la vie, qui est souvent associée à l'émergence d'un autre problème de santé.

L'insomnie peut être situationnelle, persistante ou récurrente. L'insomnie situationnelle ou aiguë ne persiste que quelques jours ou semaines et est souvent associée à des événements de vie ou à des modifications soudaines des horaires de sommeil ou de l'environnement. Elle se résout habituellement lorsque l'événement déclenchant disparaît. Chez certains individus, peut-être les plus vulnérables aux perturbations du sommeil, l'insomnie peut persister bien après l'événement déclenchant initial, probablement en raison de facteurs de conditionnement et d'un niveau de vigilance élevé. Les facteurs déclenchant l'insomnie peuvent différer de ceux qui la perpétuent. Par exemple, un sujet alité avec une blessure douloureuse et rencontrant des difficultés de sommeil peut ensuite développer des associations négatives à propos du sommeil. Un éveil conditionné peut alors perdurer et conduire à une insomnie persistante. Un mode d'évolution comparable peut survenir dans le contexte d'un stress psychologique aigu ou d'un trouble mental. Par exemple, l'insomnie survenant durant un épisode dépressif caractérisé peut devenir un sujet de focalisation avec un conditionnement négatif consécutif, et l'insomnie peut persister longtemps après la résolution de l'épisode dépressif (Nierenberg et al. 2010). Dans certains cas, l'insomnie peut se développer graduellement, sans facteur déclenchant clairement identifiable.

L'évolution de l'insomnie peut aussi être épisodique, avec des épisodes récurrents de difficultés de sommeil associés avec la survenue d'événements stressants. Le taux de chronicité est estimé entre 45 et 75 % sur un suivi de 1-7 ans (Buysse et al. 2008 ; Morin et al. 2009). Même lorsque l'insomnie se chronicise, il existe une variabilité de nuit à nuit du mode de sommeil, avec occasionnellement une nuit réparatrice qui s'intercale entre plusieurs nuits de mauvais sommeil. Les caractéristiques de l'insomnie peuvent aussi se modifier dans le temps. De nombreux individus présentant de l'insomnie ont des antécédents de sommeil « léger » ou facilement perturbé qui préexistaient aux problèmes de sommeil plus persistants.

Les plaintes d'insomnie sont plus fréquentes chez les sujets âgés ou d'âge moyen. Le type de symptômes d'insomnie varie en fonction de l'âge, les difficultés d'initiation du sommeil étant fréquentes chez les jeunes adultes et les problèmes de maintien du sommeil survenant plus souvent chez les sujets âgés et d'âge moyen (Morin et al. 2006 ; Ohayon 2002 ; Roth et al. 2006).

Les difficultés d'initiation et de maintien du sommeil peuvent aussi survenir dans l'enfance et l'adolescence mais on dispose de moins de données concernant la prévalence, les facteurs de risque et la comorbidité à ces périodes du développement. Les difficultés de sommeil dans l'enfance peuvent résulter de facteurs de conditionnement (p. ex. un enfant qui n'apprend pas à s'endormir ou à se rendormir sans la présence d'un parent) ou de l'absence d'horaires de sommeil régulier et de routines du coucher. L'insomnie à l'adolescence est souvent provoquée ou exacerbée par des horaires de sommeil irréguliers (p. ex. retard de phase). Chez l'enfant et l'adolescent, des facteurs psychologiques ou médicaux peuvent contribuer à l'insomnie.

L'augmentation de la prévalence de l'insomnie chez le sujet âgé peut s'expliquer en partie par la plus grande incidence des problèmes de santé physique avec l'âge. Les modifications des modes de sommeil en rapport avec les processus développementaux normaux doivent être différenciées de celles qui excèdent les modifications liées à l'âge. Bien que la polysomnographie n'ait qu'une valeur contributive limitée dans l'évaluation de l'insomnie, elle peut être plus utile dans le diagnostic différentiel de l'insomnie du sujet âgé parce que des facteurs étiologiques (p. ex. apnée du sommeil) sont plus souvent identifiés chez les personnes âgées.

Facteurs de risque et pronostiques

Bien que les facteurs de risque et pronostiques présentés ici augmentent la vulnérabilité à l'insomnie, les perturbations du sommeil sont plus susceptibles de survenir lorsque des individus prédisposés sont exposés à des événements déclenchants, comme des événements de vie marquants (p. ex. maladie, séparation) ou un stress quotidien peu grave mais chronique. La plupart des sujets retrouvent un sommeil normal après la disparition de l'événement déclenchant initial, mais d'autres – probablement les plus vulnérables à l'insomnie – éprouvent des difficultés de sommeil persistantes. Les facteurs perpétuant le trouble, comme de mauvaises habitudes de sommeil, des horaires de sommeil irréguliers et la crainte de ne pas dormir, alimentent le problème d'insomnie et peuvent contribuer à un cercle vicieux qui peut induire la persistance de l'insomnie.

Tempéramentaux. Une personnalité ou un style cognitif anxieux ou prompt à l'inquiétude, une prédisposition à un niveau de vigilance élevé et la tendance à refouler les émotions peuvent augmenter la vulnérabilité à l'insomnie.

Environnementaux. Le bruit, la lumière, des températures inconfortablement basses ou élevées et la haute altitude peuvent également augmenter la vulnérabilité à l'insomnie.

Génétiques et physiologiques. Le sexe féminin et le vieillissement sont associés à une vulnérabilité accrue à l'insomnie. La fragmentation du sommeil et l'insomnie montrent une prédisposition familiale. Une plus grande prévalence de l'insomnie est constatée chez les jumeaux homozygotes par rapport aux jumeaux dizygotes ; elle est aussi plus élevée chez les parents du premier degré que dans la population générale. Il reste à déterminer dans quelle mesure ce lien est hérité par une prédisposition génétique, l'apprentissage de modèles parentaux ou découle d'une autre psychopathologie (Beaulieu-Bonneau et al. 2007 ; Zhang et al. 2009).

Facteurs influençant l'évolution. Les facteurs défavorables comportent de mauvaises pratiques en matière d'hygiène de sommeil (p. ex. consommation excessive de caféine, irrégularité des horaires de sommeil).

Questions diagnostiques liées au genre

L'insomnie est une plainte plus prévalente chez la femme, avec une survenue souvent associée à la naissance d'un enfant ou à la ménopause. Malgré une prévalence plus élevée chez la femme âgée, les études polysomnographiques suggèrent qu'avec l'âge, la continuité du sommeil et le sommeil à ondes lentes sont mieux conservés chez la femme que chez l'homme.

Marqueurs diagnostiques

La polysomnographie montre habituellement des perturbations de la continuité du sommeil (p. ex. latence d'endormissement prolongée, augmentation du temps d'éveil après endormissement, diminution de l'efficacité du sommeil [pourcentage de sommeil

rapporté au temps passé au lit]) et peut montrer une augmentation du stade de sommeil 1 et une diminution des stades de sommeil 3 et 4. La sévérité de ces perturbations ne correspond pas toujours au tableau clinique présenté ou à la plainte de mauvais sommeil, les individus présentant de l'insomnie sous-estimant souvent leur temps de sommeil et surestimant leur temps d'éveil comparativement à la polysomnographie. Les analyses d'électroencéphalographie quantitative peuvent indiquer que les personnes présentant de l'insomnie ont une puissance plus élevée dans les hautes fréquences de l'électroencéphalogramme que de bons dormeurs, cela aux alentours de l'endormissement et pendant le sommeil non paradoxal, une caractéristique suggérant une majoration de l'éveil cortical (Riemann et al. 2010). Les individus présentant une insomnie peuvent avoir une diminution de la propension au sommeil et typiquement ne montrent pas de somnolence diurne excessive aux mesures objectives réalisées en laboratoire de sommeil en comparaison avec des personnes ne présentant pas de trouble du sommeil.

D'autres mesures de laboratoire identifient, bien que non systématiquement, une augmentation du niveau de vigilance et une activation générale de l'axe hypothalamo-hypophyso-adrénosurrénalien (p. ex. augmentation de la cortisolémie, de la variabilité du rythme cardiaque, de la réactivité au stress, du métabolisme de base) (Vgontzas et al. 2001). De façon générale, les résultats confortent l'hypothèse selon laquelle une activation physiologique et cognitive excessive joue un rôle significatif dans l'insomnie (Bonnet et Arand 2010 ; Riemann et al. 2010).

Les individus présentant une insomnie peuvent sembler fatigués et hagards ou, inversement, hypervigilants et « survoltés ». Toutefois, l'examen physique ne révèle pas d'anomalies systématiques ou caractéristiques. Une incidence élevée de symptômes psychophysiologiques liés au stress peut exister (p. ex. céphalées de tension, tension musculaire ou douleur, symptômes gastro-intestinaux).

Retentissement fonctionnel de l'insomnie

Des problèmes interpersonnels, sociaux et professionnels peuvent se développer suite à l'insomnie ou résultent de l'importance excessive attachée au sommeil, de l'irritabilité diurne et de la baisse de la concentration. La diminution de l'attention et de la concentration est fréquente et peut expliquer le taux élevé d'accidents observé dans l'insomnie. Les conséquences à long terme de l'insomnie persistante comportent un risque majoré d'état dépressif caractérisé (Buysse et al. 2008), d'hypertension artérielle (Suka et al. 2003) et d'infarctus myocardique (Laugsand et al. 2011), une augmentation de l'absentéisme et une baisse de la productivité au travail, une diminution de la qualité de vie et une augmentation du fardeau économique (Daley et al. 2009 ; Roth et al. 2006).

Diagnostic différentiel

Variations normales du sommeil. La durée du sommeil varie considérablement d'un sujet à l'autre. Certains individus nécessitant peu de sommeil (« petits dormeurs ») peuvent se préoccuper de la brièveté de leur sommeil. Contrairement aux individus présentant de l'insomnie, les petits dormeurs n'ont pas de difficulté à s'endormir ou à rester endormis et ne présentent pas de symptômes diurnes caractéristiques (p. ex. fatigue, problème de concentration, irritabilité). Toutefois, certains petits dormeurs peuvent souhaiter augmenter leur temps de sommeil ou tenter de le faire en prolongeant le temps passé au lit, ce qui peut engendrer un mode de sommeil ressemblant à l'insomnie. L'insomnie clinique doit aussi être distinguée des modifications normales du sommeil liées à l'âge. L'insomnie doit également être différenciée de restrictions de sommeil liées des conditions ou à des circonstances de sommeil inadéquates, par exemple suite à une urgence ou à des obligations professionnelles ou familiales contraignant l'individu à rester éveillé.

Insomnie situationnelle/aiguë. *L'insomnie situationnelle/aiguë* est une affection d'une durée de quelques jours à quelques semaines, souvent associée à des événements de vie ou des modifications des horaires de sommeil. Les symptômes de l'insomnie situationnelle ou aiguë peuvent également entraîner une détresse significative interférant avec le fonctionnement social, personnel et professionnel. Si ces symptômes sont suffisamment fréquents et remplissent tous les autres critères à l'exception de la durée de 3 mois, le diagnostic d'autre insomnie spécifiée ou d'insomnie non spécifiée est posé.

Trouble de l'alternance veille-sommeil lié au rythme circadien, type avec retard de phase et type travail posté. Les individus présentant un trouble de l'alternance veille-sommeil lié au rythme circadien du type avec retard de phase font état d'une insomnie d'endormissement seulement lorsqu'ils tentent de trouver le sommeil pendant une période conforme aux normes sociales mais ils ne signalent pas de difficulté à s'endormir ou à rester endormis lorsque leurs heures de coucher et de lever sont retardées et coïncident avec leur rythme circadien endogène. Le type travail posté diffère du trouble insomnie par les antécédents récents de travail posté.

Syndrome des jambes sans repos. Le syndrome des jambes sans repos est souvent responsable de difficultés d'initiation et de maintien du sommeil. Toutefois, le besoin pressant de bouger les jambes et toutes les sensations connexes désagréables dans les jambes sont des caractéristiques qui différencient ce trouble de l'insomnie.

Troubles du sommeil liés à la respiration. La plupart des individus présentant un trouble du sommeil lié à la respiration ont des antécédents de ronflements sonores, de pauses respiratoires pendant le sommeil et de somnolence diurne excessive. Néanmoins, jusqu'à 50 % des personnes présentant des apnées du sommeil signalent aussi des symptômes d'insomnie, une particularité plus fréquente chez la femme et les sujets âgés.

Narcolepsie. Des plaintes d'insomnie peuvent être causées par la narcolepsie qui peut être distinguée du trouble insomnie par la prédominance de symptômes de somnolence diurne excessive, de cataplexie, de paralysie du sommeil et d'hallucinations liées au sommeil.

Parasomnies. Les parasomnies sont caractérisées par des plaintes de comportements ou d'événements inhabituels pendant le sommeil qui peuvent entraîner des éveils intermittents et des difficultés à se rendormir. Toutefois, c'est plutôt l'événement comportemental, et non l'insomnie en elle-même, qui domine le tableau clinique.

Trouble du sommeil induit par une substance/un médicament, type insomnie. Le trouble du sommeil induit par une substance/un médicament, type insomnie se distingue du trouble insomnie par le fait qu'une substance (p. ex. substance donnant lieu à abus, médicament, exposition à un toxique) est jugée comme étiologiquement liée à l'insomnie (cf. « Trouble du sommeil induit par une substance/un médicament » plus loin dans ce chapitre). Par exemple, l'insomnie survenant uniquement dans un contexte de forte consommation de caféine sera diagnostiquée comme trouble du sommeil induit par la caféine, type insomnie, survenant pendant l'intoxication.

Comorbidité

L'insomnie est une comorbidité courante de nombreuses affections médicales comme le diabète, la maladie cardiaque coronarienne, la maladie pulmonaire chronique obstructive, l'arthrose, la fibromyalgie et d'autres affections chroniques douloureuses (Pearson et al. 2006). Le sens de la relation de risque semble être bidirectionnel : l'insomnie augmente les risques d'affections médicales et les problèmes médicaux majorent le risque d'insomnie. Le sens de cette relation n'est pas toujours évident et peut changer en fonction du temps ; pour cette raison, insomnie comorbide est la terminologie à

privilégier en présence d'une insomnie coexistant avec une autre affection médicale (ou un trouble mental) ([National Institutes of Health 2005](#)).

Les individus présentant une insomnie ont fréquemment un trouble mental comorbide, particulièrement des troubles bipolaires, dépressifs et anxieux ([Roth et al. 2006](#)). L'insomnie persistante est un facteur de risque ou un symptôme précoce d'un trouble bipolaire, dépressif, anxieux et d'un trouble de l'usage de substance ([Breslau et al. 1996](#)). Les individus présentant de l'insomnie peuvent faire un mésusage des médicaments ou de l'alcool pour favoriser le sommeil nocturne, d'anxiolytiques pour combattre les tensions ou l'anxiété, et de la caféine ou d'autres stimulants pour combattre l'excès de fatigue. En plus d'une aggravation de l'insomnie, ce type d'utilisation d'une substance peut conduire, dans certains cas, à un trouble de l'usage de substance.

Correspondance avec la Classification internationale des troubles du sommeil

La Classification internationale des troubles du sommeil ([American Academy of Sleep Medicine 2005](#) ; [Edinger et al. 2011](#)), 2^e édition (ICSD-2) reconnaît plusieurs phénotypes distincts d'insomnie selon l'appréciation de l'origine de l'insomnie. Elle comporte l'insomnie psychophysiologique, l'insomnie idiopathique, l'insomnie paradoxale et l'hygiène de sommeil inadéquate. Malgré leur attrait clinique et leur valeur heuristique, peu d'éléments probants soutiennent la distinction entre ces phénotypes.

Hypersomnolence

Critères diagnostiques

307.44 (F51.11)

- A. Somnolence excessive (hypersomnolence) rapportée malgré une période principale de sommeil d'au moins 7 heures et présence d'au moins un des symptômes suivants :
 - 1. Périodes de sommeil ou d'assoupissement se répétant au cours d'une même journée.
 - 2. Une période principale de sommeil prolongée d'au moins 9 heures par jour d'un sommeil non réparateur (ne permettant pas de récupérer).
 - 3. Difficulté à être totalement éveillé après un réveil brutal.
- B. L'hypersomnolence survient au moins 3 fois par semaine, pendant au moins 3 mois.
- C. L'hypersomnolence s'accompagne d'une détresse marquée ou d'une altération du fonctionnement cognitif, social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.
- D. L'hypersomnolence n'est pas mieux expliquée par un autre trouble de l'alternance veille-sommeil ni ne survient exclusivement au cours de ce trouble (p. ex. narcolepsie, trouble du sommeil lié à la respiration, trouble du sommeil lié au rythme circadien, parasomnie).
- E. L'insomnie n'est pas imputable aux effets physiologiques d'une substance (p. ex. substance donnant lieu à abus, médicament).
- F. La coexistence d'un trouble mental ou d'une autre affection médicale n'explique pas la prédominance des plaintes d'hypersomnolence.

Spécifier si :

Avec un trouble mental, y compris les troubles liés à l'usage de substances

Avec une autre affection médicale

Avec un autre trouble du sommeil

Note de codage : Le code 307.44 (F51.11) s'applique quelle que soit la spécification. L'association est mentionnée en indiquant le code du trouble pertinent (trouble mental, affection médicale ou autre trouble du sommeil) immédiatement après le code du trouble hypersomnolence.

Spécifier si :

Aigu : Durée de moins d'un mois.

Subaigu : Durée de 1 à 3 mois.

Persistant : Durée de plus de 3 mois.

Spécifier la sévérité actuelle :

Spécifier la sévérité en se fondant sur la difficulté de maintien de la vigilance diurne se manifestant par la survenue, en un jour donné, de multiples attaques irrépressibles de sommeil, par exemple dans des situations d'inactivité physique, en conduisant un véhicule, lors d'une visite chez des amis ou au travail.

Léger : Difficulté de maintien de la vigilance diurne 1 à 2 fois par semaine.

Moyen : Difficulté de maintien de la vigilance diurne 3 à 4 fois par semaine.

Grave : Difficulté de maintien de la vigilance diurne 5 à 7 fois par semaine.

Caractéristiques diagnostiques

Hypersomnolence est un terme diagnostique général qui englobe des symptômes liés à une quantité excessive de sommeil (p. ex. sommeil nocturne prolongé ou sommeil diurne involontaire), une détérioration de la qualité de l'état de veille (c.-à-d. une propension au sommeil pendant l'état de veille comme le montrent des difficultés à se réveiller et l'incapacité à rester éveillé le cas échéant) et l'inertie du sommeil (c.-à-d. une période d'altération des performances et de la vigilance dans la période de veille qui suit l'épisode de sommeil habituel ou une sieste) (critère A) (Ohayon et al., in press ; Tassi et Muzet 2000). Les individus présentant ce trouble s'endorment rapidement et ont une bonne efficacité de sommeil (> 90 %). Ils peuvent présenter des difficultés à se réveiller le matin, apparaissant parfois confus, querelleurs et ataxiques. Cette altération prolongée de l'état de veille au moment de la transition veille-sommeil est souvent appelée *inertie du sommeil* (c.-à-d. l'ivresse du sommeil). Elle peut aussi survenir au réveil d'une sieste. Pendant cette période, le sujet semble éveillé mais il présente une diminution de la dextérité motrice et parfois un comportement très inapproprié, des déficits mnésiques, une désorientation spatio-temporelle et une sensation d'hébétement et de torpeur. Cette période peut durer de quelques minutes à quelques heures.

Le besoin persistant de sommeil peut provoquer des comportements automatiques (généralement de type peu élaboré, routinier) que les sujets ne se remémorent que peu ou pas. Par exemple, ils peuvent avoir conduit pendant plusieurs kilomètres depuis l'endroit où ils pensaient être, ignorant avoir conduit de façon « automatique » pendant les minutes écoulées. Pour certains individus présentant une hypersomnolence, l'épisode principal de sommeil (la nuit, pour la plupart des individus) dure 9 heures ou plus. Toutefois, le sommeil est souvent non réparateur et suivi par des difficultés à se réveiller le matin. Pour d'autres individus présentant une hypersomnolence, la période de sommeil principale déborde de la durée d'une période normale de sommeil nocturne (6-9 heures). Dans ce cas, la somnolence excessive se caractérise par plusieurs siestes diurnes non intentionnelles. Ces siestes diurnes tendent à être relativement longues (souvent 1 heure ou plus), sont vécues comme non réparatrices (c.-à-d. non reposantes) et ne permettent pas d'améliorer la vigilance. Les personnes présentant une hypersomnolence font une sieste en journée quasi quotidiennement quelle que soit la durée du sommeil nocturne (Anderson et al. 2007). La qualité subjective du sommeil peut être estimée ou non comme bonne. Les individus sentent typiquement la somnolence survenir progressivement, plutôt que sous la forme « d'attaques » soudaines de sommeil. Le sommeil involontaire survient typiquement dans des situations où les niveaux de stimulation et d'activité sont peu élevés (p. ex. en assistant à des conférences, en

lisant, en regardant la télévision, en conduisant sur de longues distances) mais dans les cas graves, le sommeil peut survenir dans des situations mobilisant un haut niveau d'attention, comme au travail, dans des réunions ou lors d'événements mondains.

Caractéristiques associées en faveur du diagnostic

Le sommeil non réparateur, les comportements automatiques, les difficultés à se réveiller le matin et l'inertie du sommeil, quoique fréquents dans l'hypersomnolence, peuvent aussi être rencontrés dans une série d'affections, dont la narcolepsie. Environ 80 % des individus présentant de l'hypersomnolence signalent un sommeil non réparateur, et autant ont des difficultés à se réveiller le matin. L'inertie du sommeil, bien que moins fréquente (c.-à-d. observée chez 36-50 % d'individus présentant une hypersomnolence) est hautement spécifique de l'hypersomnolence (Anderson et al. 2007 ; Bassetti et Aldrich 1997 ; Vernet et al. 2010). De courtes siestes (c.-à-d. d'une durée de moins de 30 minutes) sont souvent non réparatrices (Bassetti et Aldrich 1997 ; Vernet et Arnulf 2009 ; Vernet et al. 2010). Les individus présentant une hypersomnolence apparaissent fréquemment comme endormis et peuvent même s'endormir dans la salle d'attente du médecin.

Des antécédents familiaux d'hypersomnie sont retrouvés dans un sous-groupe d'individus présentant à la fois une hypersomnolence et des symptômes évoquant un dysfonctionnement du système nerveux autonome comme des céphalées récurrentes de type vasculaire, une hyperréactivité du système vasculaire périphérique (phénomène de Raynaud) et des syncopes.

Prévalence

Environ 5-10 % des sujets consultant dans un centre du sommeil pour des plaintes de somnolence diurne sont diagnostiqués comme porteurs d'une hypersomnolence. On estime qu'environ 1 % de la population générale en Europe et aux États-Unis présente des épisodes d'inertie du sommeil (Ohayon et al. 2002 ; Ohayon et al. 2012). L'hypersomnolence se rencontre avec une fréquence relativement comparable dans les deux sexes (Ohayon et al. 2012).

Développement et évolution

L'hypersomnolence a une évolution continue, avec une progression dans la sévérité des symptômes. Dans les cas les plus extrêmes, les épisodes de sommeil peuvent durer jusqu'à 20 heures. Toutefois, la durée moyenne du sommeil nocturne se situe aux alentours de 9 h 30. De nombreux individus présentant de l'hypersomnolence sont capables de réduire leur temps de sommeil pendant les jours de travail mais ils augmentent nettement leur quantité de sommeil (jusqu'à 3 heures) en fin de semaine et pendant les vacances. Les difficultés à se réveiller sont importantes et accompagnées d'épisodes d'inertie du sommeil dans presque 40 % des cas. Dans la plupart des cas, l'hypersomnolence se manifeste pleinement vers la fin de l'adolescence ou le début de l'âge adulte, avec un âge moyen de survenue entre 17 et 24 ans (Anderson et al. 2007 ; Ozaki et al. 2008 ; Sasai et al. 2009). Les individus présentant une hypersomnolence sont diagnostiqués en moyenne 10 à 15 ans après l'apparition des premiers symptômes (Anderson et al. 2007 ; Bassetti et Aldrich 1997). Les cas chez l'enfant sont rares.

L'hypersomnolence s'installe progressivement, les premiers symptômes survenant entre 15 et 25 ans, et évolue graduellement sur des semaines à des mois. Pour la plupart des individus, l'évolution est alors continue et stable, jusqu'à l'initiation du traitement. Le développement d'autres troubles du sommeil (p. ex. trouble du sommeil lié à la respiration) peut aggraver le niveau de somnolence. Bien que l'hyperactivité puisse être l'un des signes évocateurs de la somnolence diurne chez l'enfant, les siestes

volontaires sont plus fréquentes avec l'âge. Ce phénomène normal est distinct de l'hypersomnolence.

Facteurs de risque et pronostiques

Environnementaux. L'hypersomnolence peut temporairement être aggravée par le stress psychologique ou l'utilisation d'alcool sans que l'on puisse démontrer que ces facteurs d'environnement ont un effet précipitant. Les infections virales ont été signalées comme précédant ou accompagnant l'hypersomnolence dans environ 10 % des cas (Bassetti et Aldrich 1997). Des infections virales comme la pneumonie à VIH, la mononucléose infectieuse, et le syndrome de Guillain-Barré peuvent aussi évoluer vers une hypersomnolence dans les mois qui suivent l'infection. L'hypersomnolence peut aussi survenir 6 à 18 mois après un traumatisme crânien (Masel et al. 2001).

Génétiques et physiologiques. L'hypersomnolence peut être familiale avec un mode de transmission autosomique dominant.

Marqueurs diagnostiques

La polysomnographie nocturne montre un sommeil normal ou prolongé, une courte latence d'endormissement et une continuité du sommeil normale ou accrue. La distribution du sommeil paradoxal est aussi normale. L'efficacité du sommeil est le plus souvent supérieure à 90 %. Certains individus présentant une hypersomnolence ont une augmentation de la quantité du sommeil à ondes lentes. Le test itératif de latence d'endormissement (TILE), évaluant la tendance à s'endormir, montre des latences moyennes d'endormissement se situant typiquement à moins de 8 minutes. Dans l'hypersomnolence, la latence moyenne d'endormissement est typiquement inférieure à 10 minutes et fréquemment de 8 minutes ou moins (Anderson et al. 2007 ; Bassetti et Aldrich 1997 ; Pizza et al. 2011 ; Sasai et al. 2009 ; Vernet et Arnulf 2009). Des endormissements en sommeil paradoxal (la survenue du sommeil paradoxal dans les 20 minutes qui suivent l'endormissement) peuvent être identifiés mais surviennent moins de deux fois pour quatre à cinq tentatives de siestes (Bassetti et Aldrich 1997).

Retentissement fonctionnel de l'hypersomnolence

Le faible niveau de vigilance qui se manifeste lorsque le sujet lutte contre la somnolence peut être responsable d'un manque d'efficacité, d'une mauvaise concentration et d'une mémoire déficiente pour remplir les tâches journalières. L'hypersomnolence peut provoquer une détresse significative et un dysfonctionnement dans les relations sociales et professionnelles. Le sommeil nocturne prolongé et les difficultés à se réveiller le matin peuvent conduire à des difficultés à remplir ses obligations matinales, comme arriver à l'heure au travail. Les épisodes de sommeil involontaire pendant la journée peuvent s'avérer embarrassants et même dangereux si, par exemple, ils surviennent quand la personne conduit ou travaille sur des machines.

Diagnostic différentiel

Variations normales du sommeil. La durée du sommeil « normal » varie considérablement au sein de la population générale. Les « grands dormeurs » (c.-à-d. les sujets nécessitant plus de sommeil que la moyenne générale) ne présentent pas de somnolence diurne excessive, d'inertie du sommeil ou de comportements automatiques lorsqu'ils parviennent à dormir leur quantité de sommeil requise. Le sommeil est réparateur. Si des sollicitations sociales ou professionnelles provoquent un raccourcissement du sommeil nocturne, des symptômes peuvent survenir durant la journée. Au contraire, dans l'hypersomnolence,

la somnolence excessive survient indépendamment de la durée du sommeil nocturne. Une quantité insuffisante de sommeil nocturne, ou *syndrome d'insuffisance de sommeil induit comportementalement*, peut provoquer des symptômes de somnolence diurne très semblables à ceux de l'hypersomnolence. Une durée moyenne de sommeil de moins de 7 heures par nuit suggère fortement un sommeil nocturne insuffisant et une moyenne de sommeil de plus de 9-10 heures par période de 24 heures suggère l'existence d'une hypersomnolence. Les individus présentant une quantité insuffisante de sommeil nocturne typiquement « rattrapent » leurs heures de sommeil par un sommeil prolongé les jours sans sollicitations sociales ou professionnelles ou pendant les vacances. Contrairement à l'hypersomnolence, il est improbable qu'un sommeil nocturne insuffisant demeure inchangé pendant des dizaines d'années. On ne fait pas le diagnostic d'hypersomnolence quand on suspecte une durée de sommeil nocturne inadéquate. Une épreuve à la fois diagnostique et thérapeutique consiste à demander à l'individu de prolonger son sommeil, et cela pendant 10 à 14 jours, ce qui permet souvent de clarifier le diagnostic.

Mauvaise qualité de sommeil et fatigue. L'hypersomnolence doit aussi être distinguée de la somnolence excessive en rapport avec une quantité ou une qualité de sommeil insuffisante et de la fatigue (p. ex. fatigue non forcément soulagée par le sommeil et sans rapport avec la quantité ou la qualité du sommeil). La somnolence excessive et la fatigue se différencient difficilement et peuvent se superposer considérablement.

Trouble du sommeil lié à la respiration. La somnolence diurne peut se présenter sur le même mode dans l'hypersomnolence et le trouble du sommeil lié à la respiration. La notion d'un ronflement bruyant, de pauses respiratoires pendant le sommeil, d'une lésion cérébrale ou d'une maladie cardiovasculaire dans l'anamnèse, ainsi que la présence à l'examen physique d'une obésité, d'anomalies anatomiques de l'oropharynx, d'une hypertension artérielle ou d'une défaillance cardiaque fait suggérer un trouble du sommeil lié à la respiration. La polysomnographie peut confirmer la présence d'événements apnéiques dans le trouble du sommeil lié à la respiration (et l'infirmier dans l'hypersomnolence).

Trouble de l'alternance veille-sommeil lié au rythme circadien. Le trouble de l'alternance veille-sommeil lié au rythme circadien est souvent caractérisé par de la somnolence diurne. L'histoire de la maladie révèle une anomalie des horaires veille-sommeil (horaire déplacé ou irrégulier) dans le trouble de l'alternance veille-sommeil lié au rythme circadien.

Parasomnies. Les parasomnies sont rarement associées à de la somnolence diurne ou à un sommeil nocturne continu et prolongé, caractéristiques de l'hypersomnolence.

Autres troubles mentaux. L'hypersomnolence doit être distinguée des troubles mentaux comprenant une hypersomnie comme caractéristique essentielle ou associée. Des plaintes de somnolence diurne peuvent en particulier survenir dans l'épisode dépressif caractérisé avec caractéristiques atypiques et dans la phase dépressive du trouble bipolaire. On ne porte pas le diagnostic d'hypersomnolence si l'hypersomnie survient exclusivement au cours de l'évolution d'un autre trouble mental.

Comorbidité

L'hypersomnolence peut être associée aux troubles dépressifs, aux troubles bipolaires (pendant un épisode dépressif) et au trouble dépressif caractérisé (Ohayon et al. 2012 ; Ohayon et al., in press), avec caractère saisonnier. De nombreuses personnes présentant une hypersomnolence ont des symptômes dépressifs qui peuvent remplir les critères d'un trouble dépressif. Ce tableau clinique peut être lié aux conséquences psychosociales occasionnées par le besoin permanent de sommeil. Les individus présentant une hypersomnolence risquent également de développer un trouble de l'usage de

substances, particulièrement en rapport avec une automédication par des stimulants. Ce défaut général de spécificité peut contribuer au profil très hétérogène des individus remplissant les mêmes critères diagnostiques de l'hypersomnolence. Les affections neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et l'atrophie multisystématisée, peuvent aussi être associées à l'hypersomnolence.

Correspondance avec la Classification internationale des troubles du sommeil

La Classification internationale des troubles du sommeil, 2^e édition (ICSD-2) reconnaît 9 sous-types « d'hypersomnie centrale » qui incluent l'hypersomnie récurrente (syndrome de Kleine-Levin).

Narcolepsie

Critères diagnostiques

- A. Besoin irrépressible de sommeil, assoupissement ou sieste se répétant au cours d'une même journée et survenant au moins 3 fois par semaine au cours des 3 derniers mois.
- B. Présence d'au moins un des critères suivants :
 - 1. Épisodes de cataplexie, définis selon (a) ou (b), survenant au moins plusieurs fois par mois :
 - a. Chez des individus présentant la maladie de longue date, brefs épisodes (de quelques secondes à quelques minutes) de perte soudaine et bilatérale du tonus musculaire avec maintien de la conscience déclenchés par le rire ou la plaisanterie.
 - b. Chez l'enfant et les individus présentant la maladie depuis moins de 6 mois, grimaces spontanées ou épisodes d'ouverture de la mâchoire avec protrusion linguale, ou hypotonie généralisée survenant sans lien évident avec un contenu émotionnel.
 - 2. Déficience en hypocretine estimée par immunoréactivité de l'hypocretine-1 dans le liquide céphalorachidien (LCR) (valeur inférieure ou égale à un tiers des valeurs obtenues chez des sujets sains en utilisant le même test, ou inférieure ou égale à 110 pg/mL). Les taux bas d'hypocretine-1 dans le LCR ne doivent pas avoir été mesurés dans un contexte de lésion cérébrale aiguë, d'inflammation ou d'infection.
 - 3. La polysomnographie nocturne montre une latence de sommeil paradoxal inférieure ou égale à 15 minutes, ou un test itératif de latence d'endormissement révèle une latence d'endormissement moyenne de 8 minutes ou moins et la présence de sommeil paradoxal à au moins deux reprises.

Spécifier le type :

347.00 (G47.419) Narcolepsie sans cataplexie avec déficience en hypocretine : Les exigences du critère B concernant la déficience en hypocretine et la polysomnographie/test itératif de latence d'endormissement sont satisfaites en l'absence de cataplexie (le critère B1 n'est pas rempli).

347.01 (G47.411) Narcolepsie avec cataplexie sans déficience en hypocretine : Dans ce sous-type rare de la narcolepsie (moins de 5 % des cas de narcolepsie), les exigences du critère B pour la cataplexie et la polysomnographie/test itératif de latence d'endormissement sont satisfaites et le niveau d'hypocretine-1 dans le LCR est normal (le critère B2 n'est pas rempli).

347.00 (G47.419) Ataxie cérébelleuse autosomique dominante avec surdité et narcolepsie : Une mutation de l'exon 21 de l'ADN (cytosine-5)-méthyltransférase-1 est responsable de ce sous-type caractérisé par une apparition tardive de la narcolepsie (entre 30 et 40 ans), une surdité, une ataxie cérébelleuse et finalement par une démence.

347.00 (G47.419) Narcolepsie autosomique dominante avec obésité et diabète de type 2 : La narcolepsie, l'obésité, le diabète de type 2 et un taux bas d'hypocrétine-1 dans le LCR ont été observés dans de rares cas et sont associés à une mutation du gène de la glycoprotéine myéline oligodendrocyte.

347.10 (G47.429) Narcolepsie secondaire à une autre affection médicale : Ce sous-type concerne la narcolepsie qui survient secondairement à une affection médicale responsable d'une infection (p. ex. maladie de Whipple, sarcoïdose), d'un traumatisme ou d'une destruction tumorale des neurones à hypocretine.

Note de codage (dans la CIM-9-MC, coder seulement 347.10) : Coder d'abord l'affection médicale sous-jacente (p. ex. 040.2 maladie de Whipple ; 347.10 narcolepsie secondaire à la maladie de Whipple).

Spécifier la sévérité actuelle :

Léger : Cataplexie peu fréquente (moins d'une fois par semaine), besoin de sieste seulement une ou deux fois par jour, et sommeil nocturne peu perturbé.

Moyen : Cataplexie quotidienne ou presque tous les jours, sommeil nocturne perturbé et besoin quotidien de plusieurs siestes.

Grave : Cataplexie résistante aux traitements avec plusieurs attaques quotidiennes, somnolence quasi constante et sommeil nocturne perturbé (c.-à-d. agitation, insomnie et rêves intenses).

Sous-types

Dans la narcolepsie sans cataplexie avec déficience en hypocretine, des symptômes imprécis « d'allure cataplexique » ont été signalés (p. ex. les symptômes ne sont pas déclenchés par des émotions et se prolongent inhabituellement). Dans des cas extrêmement rares, les taux d'hypocrétine dans le LCR sont bas et les résultats polysomnographiques et du test itératif de latence d'endormissement (TILE) sont négatifs ; il est conseillé de répéter ces tests avant d'établir le sous-type diagnostique. Dans la narcolepsie avec cataplexie sans déficience en hypocretine, le typage HLA pour le DQB1*06:02 peut s'avérer négatif. Des crises convulsives, des chutes ayant une autre étiologie et un trouble de conversion doivent être exclus. Dans la narcolepsie secondaire à une infection (p. ex. maladie de Whipple, sarcoïdose), à un traumatisme ou à une destruction tumorale des neurones à hypocretine, le typage HLA pour le DQB1*06:02 peut être positif à la suite de l'agression déclenchant la réponse auto-immune. Dans d'autres cas, la destruction des neurones à hypocretine peut être secondaire à un traumatisme ou à la chirurgie de l'hypothalamus. Les traumatismes crâniens ou les infections du système nerveux central peuvent toutefois réduire transitoirement les taux d'hypocrétine-1 dans le LCR sans perte de cellules à hypocretine, ce qui complique d'autant le diagnostic.

Caractéristiques diagnostiques

Les caractéristiques essentielles de la somnolence dans la narcolepsie sont des siestes récurrentes la journée et des accès subits de sommeil. Typiquement, la somnolence survient quotidiennement mais elle doit se produire au moins 3 fois par semaine pendant au moins 3 mois (critère A). En général, la narcolepsie engendre la cataplexie, qui se présente le plus couramment comme de brefs épisodes (secondes à minutes) de perte soudaine et bilatérale du tonus musculaire déclenchés par des émotions, typiquement le rire ou la plaisanterie. Les muscles du cou, de la mâchoire, des bras, des jambes ou du corps entier peuvent être affectés, ce qui entraîne des oscillations de la tête, un décrochement de la mâchoire ou une chute. Pendant la cataplexie, le sujet est éveillé et conscient. Pour remplir le critère B1(a), la cataplexie doit être déclenchée par le rire ou

la plaisanterie et être survenue au moins plusieurs fois par mois par le passé ou sans traitement approprié (Bassetti et al. 2007 ; Dauvilliers et al. 2007).

Il ne faut pas confondre la cataplexie avec la « faiblesse » survenant dans un contexte d'activités (physiologiques) sportives ou exclusivement après des émotions inhabituelles comme le stress ou l'anxiété (ce qui suggère une possible psychopathologie). Des épisodes d'une durée de plusieurs heures ou jours, ou sans lien avec une émotion, ne sont vraisemblablement pas de la cataplexie, tout comme le fait de se rouler par terre de rire (Bassetti et al. 2007 ; Dauvilliers et al. 2007).

Chez l'enfant au début de la maladie, une véritable cataplexie peut sembler atypique et affecte principalement le visage, causant des grimaces, un décrochement de la mâchoire avec protrusion de la langue (« grimace cataplectique »). Dans d'autres cas, la cataplexie peut se présenter comme une hypotonie persistante de faible amplitude responsable d'une démarche instable. Dans ces cas, le critère B1(b) peut être rempli chez l'enfant ou chez les individus présentant une maladie s'installant rapidement depuis moins de 6 mois (Bassetti et al. 2007).

La narcolepsie-cataplexie résulte presque toujours d'une perte cellulaire de neurones hypothalamiques produisant l'hypocrétine (orexine), ce qui engendre un déficit en hypocrétine (d'au moins un tiers des valeurs normales, ou 110 pg/mL pour la plupart des laboratoires). La perte cellulaire est probablement d'origine auto-immune, et environ 99 % des individus affectés sont porteurs du HLA-DQB1*06:02 (*vs* 12-38 % des sujets contrôles). Vérifier la présence du HLA-DQB1*06:02 peut donc s'avérer utile avant d'envisager une ponction lombaire pour évaluer l'immunoréactivité de l'hypocrétine-1 dans le LCR. Un taux bas d'hypocrétine-1 est rarement observé sans cataplexie, notamment chez des sujets jeunes qui peuvent développer la cataplexie plus tardivement. Le taux d'hypocrétine-1 dans le LCR est la mesure de référence, sauf en présence d'affections (neurologiques, inflammatoires, infectieuses, traumatiques) qui peuvent interférer avec cette mesure (Bourgin et al. 2008).

Une polysomnographie suivie d'un TILE peut aussi être utilisée pour confirmer le diagnostic (critère B3). Ces tests doivent être entrepris après que le sujet ait interrompu toute médication psychotrope et ait respecté un temps de sommeil approprié pendant 2 semaines (documenté par des agendas de sommeil, une actigraphie). Un raccourcissement de la latence du sommeil paradoxal (endormissement en sommeil paradoxal, latence du sommeil paradoxal inférieure ou égale à 15 minutes) pendant la polysomnographie est suffisant pour confirmer le diagnostic et remplir le critère B3. À défaut, le résultat du TILE doit être positif et montrer une latence moyenne d'endormissement inférieure ou égale à 8 minutes et au moins deux endormissements en sommeil paradoxal lors des quatre à cinq siestes (Bassetti et al. 2007 ; Dauvilliers et al. 2007).

Caractéristiques associées en faveur du diagnostic

Lorsque la somnolence est grave, des comportements automatiques peuvent survenir, le sujet continuant ses activités de façon semi-automatique, comme dans un brouillard, sans en avoir conscience ni s'en souvenir. (Bassetti et al. 2007 ; Dauvilliers et al. 2007) Approximativement 20-60 % des individus éprouvent des hallucinations hypnagogiques intenses juste avant ou au moment de l'endormissement ou des hallucinations hypnopompiques juste après le réveil (Bassetti et al. 2007 ; Dauvilliers et al. 2007 ; Ohayon et al. 1996). Ces hallucinations se distinguent de l'activité mentale onirique et non hallucinatoire que l'on rencontre normalement à l'endormissement (Ohayon et al. 1996). Cauchemars et rêves intenses sont également fréquents dans la narcolepsie, comme c'est le cas aussi dans le trouble du comportement en sommeil paradoxal. Des paralysies du sommeil à l'endormissement ou au réveil affectent 20-60 % des individus,

qui sont alors éveillés mais incapables de se mouvoir ou de parler. Toutefois, de nombreux dormeurs normaux présentent aussi des paralysies du sommeil, particulièrement suite à un stress ou à une privation de sommeil (Ohayon et al. 1999). Une alimentation nocturne peut survenir. L'obésité est courante. Une perturbation du sommeil nocturne, avec de fréquents éveils longs ou brefs, est courante et peut être invalidante.

Les individus peuvent sembler endormis ou s'endormir en salle d'attente ou pendant l'examen clinique. Lors de la cataplexie, les individus peuvent s'affaler sur leur chaise et présenter des troubles de l'élocution ou un ptosis palpébral. Si le clinicien a l'occasion de prendre les réflexes pendant la cataplexie (la plupart des attaques durent moins de 10 secondes), ils sont abolis – une constatation importante qui différencie la véritable cataplexie du trouble de conversion (Bassetti et al. 2007 ; Dauvilliers et al. 2007).

Prévalence

La narcolepsie affecte 0,02-0,04 % de la population générale dans la plupart des pays (Bassetti et al. 2007 ; Dauvilliers et al. 2007). La narcolepsie touche les deux sexes, avec une légère prédominance pour le sexe masculin.

Développement et évolution

La narcolepsie se déclare chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte jeune mais rarement chez le sujet âgé. Deux pics d'apparition sont établis, entre 15 et 25 ans et entre 30 et 35 ans. La maladie peut débiter brutalement ou avoir une évolution progressive (sur plusieurs années). La sévérité est très marquée en cas d'apparition brutale chez l'enfant, et diminue ensuite avec l'âge ou le traitement, au point que des symptômes comme la cataplexie peuvent parfois disparaître. Une apparition brutale chez le jeune enfant prépubère peut être associée à l'obésité et à une puberté précoce, un phénotype plus fréquemment observé depuis 2009. Chez l'adolescent, le mode d'apparition est plus difficilement caractérisé. Il est souvent incertain chez l'adulte, certains individus déclarant avoir présenté de la somnolence excessive depuis la naissance. Une fois établi, le trouble est persistant tout au long de la vie (Bassetti et al. 2007 ; Dauvilliers et al. 2007).

Dans 90 % des cas, les premiers symptômes sont la somnolence et un sommeil prolongé, suivis par la cataplexie (dans 50 % des cas dans l'année et dans 85 % des cas dans les 3 ans). La somnolence, les hallucinations hypnagogiques, les rêves intenses et le trouble du comportement en sommeil paradoxal (des mouvements excessifs pendant le sommeil paradoxal) sont des symptômes survenant précocement. La propension excessive au sommeil évolue rapidement vers une incapacité à rester éveillé la journée et à maintenir un bon sommeil la nuit, sans augmentation évidente du besoin de sommeil par 24 heures. Durant les premiers mois, la cataplexie peut être atypique, particulièrement chez l'enfant. En cas de début chez l'enfant prépubère, les paralysies du sommeil surviennent habituellement vers la puberté. L'exacerbation de la symptomatologie évoque un défaut d'observance du traitement médicamenteux ou le développement d'un trouble du sommeil concomitant, notamment des apnées du sommeil (Bassetti et al. 2007 ; Dauvilliers et al. 2007).

Chez les jeunes enfants et les adolescents, la narcolepsie est souvent responsable d'agressivité ou de problèmes comportementaux secondaires à la somnolence ou à la perturbation du sommeil nocturne. La charge de travail et la pression sociale augmentent au cours des études secondaires et universitaires, ce qui réduit le temps consacré au sommeil pendant la nuit. La grossesse ne semble pas modifier la symptomatologie de façon systématique. À la retraite, les sujets ont typiquement plus de temps disponible pour la sieste, ce qui diminue le besoin de stimulants. Le respect d'un horaire de sommeil régulier est bénéfique, quel que soit l'âge (Bassetti et al. 2007).

Facteurs de risque et pronostiques

Tempéramentaux. Les parasomnies, comme le somnambulisme, le bruxisme et le trouble du comportement en sommeil paradoxal, semblent être plus courantes chez les individus qui développent une narcolepsie. Ces personnes signalent couramment avoir besoin de plus de sommeil que les autres membres de la famille.

Environnementaux. Les infections pharyngées par streptocoque du groupe A, la grippe (notamment la pandémie H1N1 en 2009) ou d'autres infections hivernales sont susceptibles de déclencher des processus auto-immuns responsables quelques mois plus tard de narcolepsie. Les traumatismes crâniens et des modifications brutales des habitudes veille-sommeil (p. ex. changement de travail, stress) peuvent aussi être des facteurs déclenchants ([Bassetti et al. 2007](#) ; [Dauvilliers et al. 2007](#)).

Génétiques et physiologiques. Vingt-cinq à 32 % des jumeaux monozygotes sont concordants pour la narcolepsie. La prévalence de la narcolepsie est de 1 à 2 % chez les parents du premier degré (soit une augmentation générale du risque d'un facteur 10 à 40). La narcolepsie est fortement associée au DQB1*06:02 (99 % *versus* 12 à 38 % chez des sujets contrôles provenant de différents groupes ethniques et 25 % dans la population générale des États-Unis). En présence du DQB1*06:02, DQB1*03:01 augmente le risque, tandis que DQB1*05:01, DQB1*06:01 et DQB1*06:03 réduisent le risque, bien que ces effets soient limités. Des polymorphismes du gène de la chaîne alpha du récepteur des cellules T et d'autres gènes modulant la réponse immunitaire peuvent aussi légèrement influencer le risque ([Bourgin et al. 2008](#) ; [Kornum et al. 2011](#)).

Questions diagnostiques liées à la culture

La narcolepsie a été décrite dans tous les groupes ethniques et dans de nombreuses cultures. Chez les Afro-Américains, la plupart des cas se présentent sans cataplexie ou avec une cataplexie atypique, ce qui complique le diagnostic, particulièrement en présence d'obésité et d'apnées du sommeil ([Bassetti et al. 2007](#)).

Marqueurs diagnostiques

L'imagerie fonctionnelle suggère une altération des réponses hypothalamiques à des facteurs humoraux. Une polysomnographie nocturne suivie d'un TILE est utilisée pour confirmer le diagnostic de narcolepsie, particulièrement lorsque le trouble vient d'être diagnostiqué et avant de débiter le traitement, et si le déficit d'hypocrétine n'a pas été établi biochimiquement. La polysomnographie/TILE doit être réalisée après que le sujet ait interrompu toute médication psychotrope, et quand il a été documenté que les horaires veille-sommeil sont réguliers, sans travail posté ni privation de sommeil.

Un endormissement en sommeil paradoxal (latence du sommeil paradoxal inférieure ou égale à 15 minutes) est très spécifique (environ 1 % de cas positifs chez les sujets contrôles) mais modérément sensible (environ 50 %). Un résultat positif au TILE inclut une latence moyenne d'endormissement inférieure ou égale à 8 minutes et au moins deux endormissements en sommeil paradoxal lors des quatre à cinq siestes du test. Les résultats du TILE sont positifs chez 90 à 95 % des individus présentant une narcolepsie comparativement à 2-4 % chez des sujets contrôles ou des personnes présentant un autre trouble du sommeil. Des résultats polysomnographiques supplémentaires comportent de fréquents microéveils, une diminution de l'efficacité du sommeil et une augmentation du premier stade de sommeil. Des mouvements périodiques des jambes (constatés chez 40 % des individus présentant une narcolepsie) et des apnées du sommeil sont souvent observés ([Bassetti et al. 2007](#) ; [Dauvilliers et al. 2007](#)).

La déficience en hypocretine est démontrée par la mesure de l'immunoréactivité de l'hypocretine-1 dans le LCR ([Bourgin et al. 2008](#)). Ce test est particulièrement utile

chez les individus suspects d'un trouble de conversion, ceux présentant une cataplexie atypique ou dans des cas réfractaires au traitement. La valeur diagnostique du test n'est pas affectée par les traitements médicamenteux, la privation de sommeil, une rythmicité circadienne mais les résultats ne sont pas interprétables en cas de maladie grave suite à une infection concomitante, de traumatisme crânien ou d'état comateux (Bourgin et al. 2008). La cytorachie, la protéinorachie et la glycorachie sont dans des valeurs normales même pour un prélèvement réalisé dans les semaines qui suivent un déclenchement brutal de la maladie. Dans les cas débutants, le taux d'hypocrétine-1 dans le LCR est typiquement effondré ou non détectable (Bourgin et al. 2008).

Retentissement fonctionnel de la narcolepsie

La conduite d'un véhicule et le travail sont perturbés, et les individus atteints de narcolepsie doivent éviter les tâches qui les exposent eux-mêmes (p. ex. travail sur machine) ou autrui (p. ex. conducteur de bus, pilote) à un danger. Lorsque la narcolepsie est contrôlée par le traitement, les patients peuvent habituellement conduire, bien que rarement seuls, sur de longues distances. Les individus non traités présentent aussi un risque d'isolement social et de se blesser (ou de blesser autrui) accidentellement. Les relations sociales peuvent être affectées, les sujets s'efforçant d'éviter la cataplexie en contrôlant leurs émotions (Bassetti et al. 2007 ; Dauvilliers et al. 2007).

Diagnostic différentiel

Autres hypersomnies. L'hypersomnolence et la narcolepsie sont similaires en termes de sévérité de la somnolence diurne, d'âge de début et de stabilité de l'évolution dans le temps mais se différencient à partir de certaines caractéristiques cliniques et paracliniques distinctes. Les individus présentant une hypersomnolence ont typiquement un sommeil nocturne plus long et moins perturbé, de plus grandes difficultés à se réveiller, une somnolence diurne plus persistante (à l'inverse des « attaques de sommeil » plus ponctuelles dans la narcolepsie), des épisodes de sommeil diurne plus longs et moins réparateurs, et peu ou pas de rêves pendant les siestes diurnes. Inversement, les individus atteints de narcolepsie ont de la cataplexie et des intrusions répétées d'éléments de sommeil paradoxal lors des transitions veille-sommeil (p. ex. hallucinations liées au sommeil et paralysies du sommeil). Le TILE démontre typiquement des latences d'endormissement raccourcies (c.-à-d. une augmentation de la somnolence physiologique) et la présence de plusieurs endormissements en sommeil paradoxal chez les individus présentant de la narcolepsie.

Privation de sommeil et insuffisance de sommeil nocturne. La privation de sommeil et l'insuffisance de sommeil nocturne sont courantes chez l'adolescent et les travailleurs postés. Chez l'adolescent, les difficultés d'endormissement sont courantes et provoquent une privation de sommeil. Les résultats du TILE peuvent être positifs s'il est réalisé chez un individu en privation de sommeil ou qui présente un sommeil en retard de phase.

Syndrome d'apnées du sommeil. Les apnées du sommeil sont particulièrement probables en présence d'obésité. Comme les apnées du sommeil sont plus fréquentes que la narcolepsie, la cataplexie peut avoir été ignorée (ou absente) ; dans ce cas on peut croire que la personne présente des apnées obstructives du sommeil et qu'elle ne répond pas au traitement.

Trouble dépressif caractérisé. La narcolepsie et l'hypersomnolence peuvent être associées ou confondues avec la dépression. La cataplexie n'est pas présente dans la

dépression. Les résultats du TILE sont le plus souvent normaux, et il existe une discordance entre la somnolence subjective et objective, telle qu'elle est évaluée par la latence moyenne d'endormissement pendant le TILE.

Trouble de conversion (trouble à symptomatologie neurologique fonctionnelle). Des caractéristiques atypiques, comme une cataplexie prolongée ou des déclencheurs inhabituels peuvent être présentes dans le trouble de conversion (trouble à symptomatologie neurologique fonctionnelle). Les individus peuvent signaler de la somnolence et de l'onirisme, cependant sans que les caractéristiques d'endormissement en sommeil paradoxal ne soient identifiées au TILE. Un épisode prolongé de véritable pseudo-cataplexie peut survenir pendant la consultation, ce qui laisse le temps au médecin examinateur de constater que les réflexes sont intacts.

Déficit de l'attention/hyperactivité et autres problèmes comportementaux. Chez l'enfant et l'adolescent, la somnolence peut occasionner des problèmes comportementaux comme l'agressivité et l'inattention, ce qui peut conduire à un diagnostic erroné de déficit de l'attention/hyperactivité.

Convulsions. Chez le jeune enfant, la cataplexie peut être diagnostiquée de façon erronée comme étant des convulsions. Les convulsions ne sont pas couramment déclenchées par les émotions et, lorsqu'elles le sont, le déclencheur n'est pas le rire ou la plaisanterie. Lors d'une convulsion, les individus sont plus susceptibles de se blesser lorsqu'ils chutent. Les convulsions caractérisées par une atonie isolée sont rarement observées sans qu'il existe d'autres types de convulsions, et ont également une signature électroencéphalographique.

Chorée et troubles moteurs. Chez le jeune enfant, la cataplexie peut être diagnostiquée de façon erronée comme étant une chorée ou un trouble neuropsychiatrique auto-immun de l'enfant associé à une infection à streptocoque, particulièrement dans un contexte d'infection pharyngée avec des taux élevés d'anticorps antistreptolysine O. Certains enfants peuvent présenter des troubles moteurs se superposant à l'apparition de la cataplexie.

Schizophrénie. Les individus éprouvant des crises hallucinatoires intenses peuvent penser que ces expériences sont réelles – une caractéristique qui suggère la schizophrénie. De même, des idées délirantes de persécution peuvent se développer avec les traitements psychostimulants. Si la cataplexie est présente, le clinicien doit d'abord s'assurer que ces symptômes sont secondaires à la narcolepsie avant d'envisager un diagnostic concomitant de schizophrénie.

Comorbidité

La narcolepsie peut survenir concomitamment aux troubles bipolaires, dépressifs et anxieux et dans de rares cas à la schizophrénie. La narcolepsie est aussi associée à un indice de masse corporelle élevé ou à l'obésité, particulièrement lorsque la narcolepsie n'est pas traitée. Une prise de poids rapide est courante lorsque la narcolepsie s'installe brutalement chez le jeune enfant. Une comorbidité avec les apnées du sommeil doit être considérée lorsqu'une soudaine aggravation d'une narcolepsie préexistante est constatée.

Correspondance avec la Classification internationale des troubles du sommeil

La Classification internationale des troubles du sommeil, 2^e édition (ICSD-2) reconnaît 5 sous-types de narcolepsie.